ONEMA-POP-035 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-035 — Abordagem da Dispneia e Conforto Respiratório no
Fim da Vida

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar abordagem da dispneia e conforto respiratório no fim da vida na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação,
execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Dispneia em
pessoa com doença avançada e plano paliativo; investigar causas potencialmente reversíveis conforme objetivos acordados. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: oxímetro quando indicado, materiais de avaliação e apoio postural; paciente: ventilador portátil se tolerado, oxigênio e fármacos apenas se prescritos. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Intensidade subjetiva da falta de ar, padrão respiratório, ansiedade, dor, secreções, febre, SpO2 quando pertinente, preferências e plano antecipado. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer
linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar objetivos de cuidado e decisões antecipadas documentadas; não presumir que dispneia seja inevitável.

2. Perguntar intensidade e sofrimento percebido; observar fala, esforço, frequência e posição de conforto.

3. Investigar causas tratáveis dentro do plano, como congestão, infecção, broncoespasmo ou derrame.

4. Oferecer posição sentada ou lateral de preferência, ambiente calmo, ventilação facial suave se confortável.

5. Evitar oxigênio rotineiro apenas por sensação de falta de ar; verificar indicação clínica de hipoxemia e prescrição.

6. Conferir e administrar medicação sintomática somente com prescrição e monitorar efeitos.

7. Se desconforto persistente, acionar equipe paliativa para revisão urgente do plano e da via de administração.

8. Reavaliar conforto, comunicar família com linguagem clara e registrar resposta e decisões.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dispneia inesperada grave sem plano paliativo compatível, cianose, alteração súbita de consciência ou suspeita de evento

reversível agudo: acionar suporte emergencial conforme desejos e diretivas válidas. Em emergência, acionar SAMU 192 e

registrar horário e destinatário; não retardar atendimento por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Ensinar posicionamento e técnicas de conforto, evitando impor oxigênio ou intervenções contra preferências expressas.

Confirmar compreensão por retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências,

orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 NICE NG31 — Care of dying adults in the last days of life —

https://www.nice.org.uk/guidance/ng31/chapter/Recommendations

 OMS — Palliative care, fact sheet — https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem —

https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/